

Le service social hospitalier

Un acteur central du parcours patient

Jérôme PENOT Responsable du service social hospitalier, référent social de la PASS, référent handicap patient, cadre supérieur socio-éducatif Hôpitaux universitaires de Strasbourg

Le service social hospitalier assure un rôle essentiel de sécurisation et d'humanisation des parcours de soins. Pourtant, sa reconnaissance institutionnelle reste incomplète. Face aux mutations profondes du système de santé et à la montée des précarités, les assistants de service social hospitaliers (ASSH) sont des professionnels incontournables pour assurer l'articulation entre l'hôpital, le patient et son environnement. Cette contribution rappelle leur rôle stratégique, les enjeux de reconnaissance de la filière socio-éducative et les perspectives à envisager.

Interface des services de soins, des partenaires du territoire et des usagers, les assistants de service social hospitaliers (ASSH) interviennent à chaque étape : préparation des sorties, maintien et accès aux droits, protection des plus fragiles, coordination des interventions médico-sociales, accompagnement des

situations complexes, soutien aux familles et aux équipes. Leur mission dépasse largement la seule organisation logistique, comme l'a mis en lumière la crise sanitaire, renforçant la démonstration de leur rôle pivot.

Des périmètres d'intervention spécifiques

Face au virage ambulatoire, à la réduction des durées d'hospitalisation et à l'essor des maladies chroniques, les ASSH assurent une continuité du lien social et du soin. Ils interviennent au plus près des patients et des équipes, tant en intra qu'en extra-hospitalier, et ce dans tous les champs : psychiatrie, gériatrie, soins palliatifs, permanence d'accès aux soins, accompagnement du personnel hospitalier via le service social du travail.

Psychiatrie, continuité et pertinence des prises en charge

Au sein des unités d'hospitalisation adulte du pôle de psychiatrie d'un CHU, les missions de l'ASSH s'inscrivent dans une stratégie institutionnelle visant à garantir l'accès aux soins, fluidifier les parcours et prévenir les ruptures pour les publics vulnérables. Elles reposent principalement sur l'évaluation médico-psychosociale dès l'admission ; la construction d'un projet de sortie en cohérence avec le projet de soins et de vie du patient et de sa famille et un travail de coordination interinstitutionnelle avec les acteurs des champs sanitaire, social et médico-social. Les ASSH contribuent aux enjeux institutionnels de régulation des lits, de maîtrise de la durée moyenne de séjour (DMS) et de prévention des ruptures de parcours ou des hospitalisations itératives lors des transitions hôpital/domicile/structure, dans un objectif de continuité et de pertinence des prises en charge. **ENCADRÉ 2**

SERVICE SOCIAL HOSPITALIER LES CHIFFRES CLÉS

ENCADRÉ 1

- Environ **4 000 assistants** de service social hospitaliers (ASSH) exercent en France.
- Plus de **70 %** sont positionnés en services somatiques et en psychiatrie.
- Près de **30 %** interviennent dans des dispositifs spécifiques : PASS, soins palliatifs, unités d'addictologie, équipes mobiles.
- Environ **450 dispositifs PASS** sont recensés en France. Près de **90 %** mobilisent des assistants de service social hospitaliers.

Une approche gériatrique globale, réactive et adaptée

L'équipe mobile d'évaluation gériatrique fait partie de la filière gériatrique hospitalière. Elle est constituée d'une équipe pluridisciplinaire, transversale, mobile qui intervient auprès de patients âgés de plus de 75 ans, à la demande des équipes, aux urgences et dans l'ensemble des services de l'établissement. Sa mission est de repérer les personnes âgées fragiles et d'optimiser leur prise en charge par une approche gériatrique globale (évaluation médico-psychosociale). L'équipe mobile extrahospitalière intervient à domicile ou en EHPAD, à la demande des médecins traitants ou médecins coordonnateurs. Cette filière s'appuie sur un large réseau partenarial et sur la filière gériatrique pour assurer un accompagnement global, réactif et adapté. Elle constitue un véritable outil de continuité et de fluidité du parcours de soins. **ENCADRÉ 3**

Accueillir, conseiller et soutenir les patients et leurs proches

En soins palliatifs, les ASSH accompagnent les patients et leurs familles dans les démarches en lien avec le projet de vie. Ils évaluent et organisent les projets de retour à domicile ou d'entrée en établissement. Ils peuvent être amenés à fournir des informations d'ordre juridique concernant la situation familiale ou les droits des conjoints survivants. Ils soutiennent les familles dans les démarches post-décès. C'est un travail en équipe pluridisciplinaire (médecin, cadre, IDE...) pour envisager toutes les solutions qui pourraient être adaptées en fonction de l'état de santé de la personne, de l'évolution de la maladie ainsi que de l'autonomie. **ENCADRÉ 4**

PASS, prise en charge des patients les plus vulnérables

Dans le cadre de la permanence d'accès aux soins de santé (PASS), l'assistante de service social hospitalière intervient auprès de personnes en situation de précarité, sans droits ou avec des droits partiels, qu'elles soient françaises ou étrangères, en situation régulière ou irrégulière. Son rôle consiste à garantir un accès effectif aux soins en proposant systématiquement une consultation sociale, une consultation paramédicale et médicale. Elle assure une évaluation globale de la situation, l'ouverture ou la régularisation des droits, la collaboration et coordination avec les partenaires internes (médecins, paramédicaux, facturation, etc.) et externes. L'intervention pluridisciplinaire apporte une prise en charge complète dans l'offre de soin et assure la délivrance des traitements par l'officine hospitalière.

Elle accompagne le patient jusqu'à son entrée dans les dispositifs de droit commun, assure la traçabilité dans le dossier patient et tient à jour les statistiques de la PASS dans un rôle d'observatoire sur le territoire. **ENCADRÉ 5**

Accompagnement individuel des professionnels

L'assistante sociale du travail a pour mission essentielle de faciliter la conciliation entre la vie personnelle et familiale des agents hospitaliers et leur vie professionnelle. Le service social du



LAURA SABATIER **ENCADRÉ 2**

Assistante de service social, CHU de Clermont-Ferrand

PSYCHIATRIE, QUAND LA COMPLEXITÉ APPELLE LA GOUVERNANCE PARTAGÉE

Une situation « type » marquante de ma pratique se porte sur la gestion des situations dites « complexes ». Ce terme générique est beaucoup employé à l'heure actuelle par l'ensemble des professionnels exerçant dans les champs sanitaire, social et médico-social. Or, force est de constater que la notion de complexité ne revêt pas la même définition pour les institutions de ces champs d'intervention. Le manque de communication interinstitutionnelle, l'absence de gouvernance partagée, pensée et structurée autour de ce sujet me semble être le type même de situation donnant lieu à discussion pour favoriser le concept d'« intelligence collective », dans l'objectif de créer et d'innover de nouvelles méthodes de travail en faveur du patient hospitalisé.



ALEXANDRA DUBRAY **ENCADRÉ 3**

Assistante de service social à l'équipe mobile d'évaluation gériatrique du CH de Cornouaille Quimper

ÉQUIPE MOBILE DE GÉRIATRIE : LE RÔLE CLÉ DU RÉSEAU DANS LA PRISE EN CHARGE

Il est parfois difficile de gérer l'épuisement des aidants ou le refus d'aide des personnes âgées malgré leur fragilité. Le manque de solutions disponibles sur le territoire peut se révéler frustrant. Nous sommes parfois confrontés à des patients isolés, sans famille ni entourage connu, ce qui complexifie la prise en charge. En l'absence de famille, il est souvent nécessaire de procéder à une véritable investigation, « un travail d'enquête ». Nous avons ainsi été sollicités pour un patient âgé de 80 ans, hospitalisé pour « errance dans un contexte de troubles cognitifs ». Lors de l'entretien, l'homme tenait des propos que nous avons initialement attribués à ses troubles : il affirmait posséder un caniche royal, un cacatoès et un boa. En contactant différents services, nous avons découvert avec surprise que ces animaux étaient bel et bien présents chez lui, laissés sans surveillance. Nous avons dû sécuriser en urgence à la fois le domicile, le patient et ses animaux. Cette anecdote met en évidence l'importance d'une analyse approfondie des situations. Sans le soutien de notre réseau, nous n'aurions pas pu rassembler les informations essentielles nécessaires pour assurer la poursuite de la prise en charge de ce patient.

travail est un service de la direction des ressources humaines (DRH) et est donc un acteur privilégié dans la mise en œuvre de la politique sociale de l'établissement de santé. Son action s'inscrit dans une démarche à la fois d'accompagnement individuel des personnes, pour aider les agents dans la résolution de leurs difficultés personnelles,

de prévention des risques professionnels et de médiation institutionnelle. Ces missions contribuent à maintenir d'un environnement de travail sain et sécurisé, essentiel pour la mission principale de l'hôpital : soigner. **ENCADRÉ 6**

Des alliés précieux pour les familles

Les équipes du service social hospitalier jouent un rôle clé dans l'accompagnement des aidants, souvent confrontés à des défis humains, logistiques et émotionnels. Leur expertise permet d'identifier les besoins spécifiques des proches qui soutiennent les patients, notamment en cas de pathologies chroniques, de handicap ou de perte d'autonomie. En évaluant la situation globale du patient et de son entourage, les assistants de service social repèrent les fragilités des aidants et les risques d'épuisement, tout en proposant des solutions adaptées. Ils facilitent l'accès aux droits et aux dispositifs d'aide pour soulager la charge quotidienne des aidants. Leur connaissance fine des réseaux territoriaux leur permet de coordonner des réponses personnalisées, en lien avec les équipes soignantes et les partenaires extérieurs. Les assistants de service social agissent aussi comme médiateurs entre les aidants, les équipes soignantes et les partenaires, afin de garantir une continuité dans l'accompagnement. Ils informent sur les démarches complexes (protection juridique, aides financières) et aident à mobiliser les ressources de proximité, souvent méconnues des familles. Leur présence est essentielle pour prévenir l'isolement des aidants, en les orientant vers des groupes de parole ou des formations. Ils contribuent ainsi à préserver leur santé et leur équilibre, tout en sécurisant le retour à domicile du patient.

Des expertises à valoriser

Les assistants de service social hospitaliers disposent de compétences spécifiques, trop souvent méconnues : expertise du droit social et médico-social, connaissance fine des ressources territoriales, capacité de médiation, aptitude à construire des projets individualisés dans des délais contraints.

La coordination renforcée des parcours complexes et l'accompagnement du personnel hospitalier via le service social du travail illustrent l'importance stratégique de ces professionnels dans la qualité des prises en charge.



◀ **MARION BARDOUIL** **ENCADRÉ 4**
Assistante de service social
CHU de Brest, site de Carhaix
Référente de l'USP

SOINS PALLIATIFS : UN SERVICE PLEIN DE VIE

Au début de ma prise de poste, et encore aujourd'hui parfois, il y a de l'appréhension à s'entretenir avec des personnes en fin de vie, parfois pour parler d'un « devenir », d'un « projet de vie », avec l'impression d'une dissonance entre mon discours et la réalité que les patients vivent. Un jour, une patiente atteinte

d'une pathologie dégénérative de la lèvre inférieure, avec une lésion importante au niveau du visage (plaie visible, nécrosée), a demandé à me voir. En staff, il avait été demandé à l'équipe de faire attention aux expressions faciales face à cette plaie, afin de ne pas mettre la patiente mal à l'aise. Malgré une appréhension très forte, l'entretien s'est bien passé, avec une discussion ponctuée de pointes d'humour. J'ai été particulièrement surprise de constater la vie qu'il y a dans ce service : l'humour, les petites attentions (les soignants qui vont acheter des glaces aux patients quand il fait chaud), les sorties (accompagnement de deux patients au festival de musique de la ville) et les temps un peu hors du soin (des proches d'une patiente qui ont donné un récital de musique ou encore la fille d'une patiente décédée dans le service qui vient faire un repas crêpes dans le service) qui font du bien.



◀ **NADINE BERTRAND** **ENCADRÉ 5**
CARLA SZCZEPANIAK
Assistants de service social
CH de Lens

LES PASS, DISPOSITIFS ESSENTIELS POUR LES PUBLICS PRÉCAIRES

La prise en charge des patients précaires est une mission dévolue à l'hôpital public dans le cadre de ses dispositifs réglementaires. Les situations les plus fréquentes concernent des personnes

sans droits ou avec des droits partiels, souvent en rupture de parcours de soins, françaises ou étrangères. Les difficultés sont nombreuses : barrière de la langue, complexité administrative croissante ou encore méconnaissance du dispositif par certains partenaires. Ce qui nous porte, c'est la richesse humaine : la diversité des parcours, la force des patients, la collaboration pluriprofessionnelle. Nous avons ainsi suivi une femme roumaine malvoyante, vivant en squat depuis dix ans, sans droits ni soins. Grâce à un accompagnement intensif via la PASS, elle a retrouvé un parcours de soins, intégré les « lits halte soins santé » et elle bénéficie aujourd'hui d'un suivi médico-social stable. Une réussite collective qui illustre le sens profond de notre mission, amenant progressivement nos patients vers le droit commun et l'inclusion.

Le cadre socio-éducatif : un pilier essentiel

Le cadre socio-éducatif incarne un maillon indispensable, à la croisée des enjeux humains, organisationnels et territoriaux. Son rôle dépasse largement le cadre traditionnel de l'encadrement : il est avant tout un soutien quotidien pour les équipes, garant de leur cohésion et de leur montée en compétences. Face à la complexité croissante des prises en charge, il accompagne les professionnels de terrain, les aide à décrypter les situations sociales et médico-sociales et favorise une approche pluridisciplinaire, indispensable pour répondre aux besoins multidimensionnels des patients. En analysant les dynamiques sociales et les évolutions réglementaires, il éclaire les décisions stratégiques. Il agit comme un relais entre le terrain et la gouvernance, traduisant les réalités des usagers et des soignants en orientations concrètes, tout en veillant à l'adéquation entre les ressources disponibles et les besoins identifiés. Conscient que la santé s'inscrit dans un écosystème élargi, il tisse et entretient un réseau partenarial dense avec les acteurs de la santé, du social et du médico-social du territoire. Cette collaboration active – avec les associations, les collectivités, les services de l'État – permet de créer des parcours de soins fluides et adaptés, surtout pour les populations les plus fragiles. En période de crise sanitaire ou sociale, ce réseau devient un levier déterminant pour mobiliser rapidement des solutions innovantes et solidaires.

Dans un contexte marqué par la précarité grandissante et la vulnérabilité accrue des publics accueillis, son action prend une dimension encore plus stratégique. Il anticipe les risques de rupture, identifie les ressources mobilisables et contribue à bâtir des réponses globales, où la santé ne se limite pas à l'aspect médical. Acteur incontournable des organisations sanitaires, le cadre socio-éducatif incarne ainsi une vision humaniste et systémique de la santé. Son engagement au quotidien rappelle une évidence : soigner, c'est aussi écouter, accompagner et relier.

Une filière à conforter dans l'organisation hospitalière

Malgré un passage en catégorie A, les écarts de rémunération persistants entre les filières socio-éducatives et soignantes fragilisent l'attractivité et la fidélisation des professionnels, limitant le renouvellement des compétences. Il devient indispensable de revaloriser les grilles indiciaires en cohérence avec l'expertise mobilisée ; développer des parcours professionnels

structurés : coordination, pratiques avancées, expertises spécifiques ; reconnaître l'investissement des ASSH dans l'encadrement, l'enseignement et l'ingénierie de projet ; renforcer leur représentation dans les instances hospitalières, en ouvrant la voie à la création de directions de l'action sociale.

Véritable maillon stratégique entre l'hôpital, le patient et la cité, le service social hospitalier contribue pleinement à l'efficacité et à l'humanité du système de santé. La reconnaissance de la filière socio-éducative constitue aujourd'hui un enjeu majeur pour répondre aux défis actuels et futurs de l'hôpital et du système de santé dans son ensemble. ■



VIRGINIE KERIBEDJ ENCADRÉ 6
Assistante de service social
CHU de Lille

SERVICE SOCIAL DU TRAVAIL : SOUTENIR LES AGENTS POUR SOUTENIR LES SOINS

Les demandes que je rencontre le plus fréquemment concernent le logement. Il y a aussi de nombreuses difficultés financières, souvent en lien avec des séparations, les moments de vie où tout se bouscule. Et puis, bien sûr, les difficultés en lien avec le travail :

épuisement professionnel, handicap, inaptitude médicale, conflits, harcèlement... La DRH peut également nous solliciter pour réaliser une évaluation globale des situations de personnes dans des situations d'absentéisme chronique, dans le cas de démarches disciplinaires... Nous intervenons toujours dans le respect et avec l'accord des personnes, et bien sûr dans le cadre du secret professionnel. Le plus difficile, c'est souvent de devoir composer avec l'urgence et les limites des moyens disponibles. Et il y a la charge émotionnelle : être témoin de détresse, de souffrance ou de situations de vulnérabilités demande de garder un équilibre, de rester disponible pour les autres tout en prenant soin de soi. Être assistante sociale du travail dans un hôpital, ce n'est pas seulement aider des agents, c'est aussi un métier stratégique, car chaque accompagnement réalisé soutient la mission vitale de l'hôpital et contribue à la qualité des soins.

APROSSHES ENCADRÉ 7

UN RÉSEAU PROFESSIONNEL AU SERVICE DE L'INTERVENTION SOCIALE EN SANTÉ

L'Association professionnelle des services sociaux hospitaliers et de santé (APROSSHES) rassemble depuis près de 30 ans les professionnels des services sociaux intervenant en milieu hospitalier et dans le secteur de la santé. Son objectif : animer, partager et soutenir les acteurs engagés auprès des patients et des agents hospitaliers, dans des établissements publics ou privés. Présente dans 36 départements, l'association s'appuie sur un réseau actif, organisé en sous-groupes régionaux pour être au plus près des réalités de terrain. À travers des rencontres régionales et nationales, elle contribue à la promotion de la profession et à l'harmonisation des pratiques. Son site centralise ressources, actualités et témoignages et permet de découvrir les actions menées pour soutenir les patients, les agents et les équipes sociales. www.aprosshes.fr